Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001362-39.2025.8.21.0155/RS

AUTOR: ROSENILDA DA LUZ DE JESUS DE VARGAS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ROSENILDA DA LUZ DE JESUS DE VARGAS ajuizou ação ordinária em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** alegando possuir diagnóstico de patologia registrada sob o CID 10 **C49** (**"Neoplasia Maligna do Tecido Conjuntivo - Tumor Estromal Gastrointestinal"**) e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Sunitinibe 50mg**. Requereu, liminarmente, o fornecimento do tratamento postulado. No mérito, pugnou pela procedência do pedido com a confirmação da medida de urgência.

Deferida a gratuidade de justiça ao autor e requisitada nota técnica (evento 8, DESPADEC1), sobreveio com parecer favorável (evento 12, NOTATEC1).

Concedida a antecipação de tutela (evento 15, DESPADEC1).

Citado, o réu apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda (evento 26, CONT1).

Sobreveio réplica (evento 30, RÉPLICA1).

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de outras provas (evento 32, DESPADEC1), nada requereram.

O Ministério Público emitiu parecer de mérito, defendendo a procedência da ação (evento 41, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

Passo a fundamentar.

Não sendo necessária a produção de outras provas, é caso de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tratou dos requisitos para o fornecimento de medicamentos na via judicial, por meio dos Temas n°s 1234 e 6, que geraram as respectivas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, abaixo reproduzidas:

> *Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*
>
> *Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Através da edição o Tema nº 06, o STF fixou a tese de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

> *(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;*
>
> *(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;*
>
> *(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;*
>
> *(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;*
>
> *(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e*
>
> *(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento*

A prestação jurisdicional, todavia, não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

Segundo laudo médico acostado ao feito (evento 1, LAUDO7), o autor é portador de patologia registrada sob o CID 10 C49, necessitando do uso do medicamento Sunitinib:

Paciente de 44 anos, com o diagnóstico de Neoplasia do estroma Gastrointestinal (cólon) em junho de 2021, metastático em sua apresentação inicial para peritônio, iniciou tratamento com Imatinib paliativo em julho de 2021. Submetida a hemicolectomia esquerda com anastomose primária por perfuração tumoral em 20/08/21 (impressão do ressecção completa - tumor primário + doença a distância); mantido Imatinib na dose de 400mg/m2 dia, porém paciente apresentou diarréia, tendo sido reduzida dose para 400mg/m2 a cada 2 dias. Em tomografias de reavaliação de setembro de 2022, apresentou progressão de doença em pelve, tendo retomada dose de Imatinib 400mg/m2 dia, apresentando novamente progressão de doença em tomografias de reavaliação de maio de 2023. Optado por aumentar dose de Imatinib para 800mg/m2 dia, em julho de 2023, mas, por toxicidade, retomada dose de 400mg/m2 dia em janeiro de 2024, tendo paciente apresenta nova progressão de doença (peritônio + lesão próximo à anexial à direita) em junho de 2024. Mantido Imatinib na dose tolerada pelo paciente (400mg/m2 dia), constatada doença estável em imagens de setembro de 2024. Em nova reavaliação em janeiro de 2025, paciente apresentou progressão de doença em adbome (aumento das dimensões do nódulo junto à superfície hepática posterior da transição dos segmentos VI e VII do fígado, medindo 4,6 x 2,0 cm; aumento das dimensões da formação expansiva sólida na pelve posterior à direita, em íntimo contato com útero e especialmente com anexo deste lado, com realce heterogêneo, medindo aproximadamente 7,0 x 5,2 cm; estabilidade das dimensões dos demais nódulos peritoneaias na pelve).

Tendo em vista o benefício documentado da medicação com Sutinibe, solicitamos a saúde suplementar o início do tratamento com tal medicação.

Explicar quais os efeitos benéficos do uso do fármaco/tratamento prescrito não integrante das listas padronizadas do SUS e/ou Protocolos Clínicos e indicar qual o grau de eficácia do medicamento/tratamento.

O sunitinibe é opção terapêutica para pacientes que apresentam progressão de doença na vigência de imatinibe em dose otimizada. Não há outra opção terapêutica eficaz na lista de medicamentos do SUS.

Fazer comparação entre os fármacos/tratamentos das(os) Listas/Protocolos Clínicos e os que não integram, apresentando Evidências Científicas e Estudos Literários atuais do fármaco/tratamento prescrito que não integra as Listas/Protocolos Clínicos da rede pública, demonstrando que são mais eficazes para o controle da moléstia.

Um estudo inicial aberto, de titulação de dose, foi conduzido em indivíduos com GIST após falha do imatinibe (mediana de dose máxima diária de 800 mg) em decorrência de resistência ou intolerância. Noventa e sete indivíduos foram incluídos receberam 50 mg no esquema de tratamento recomendado, ou seja, 4 semanas com tratamento e 2 semanas sem tratamento (esquema 4/2).

Nesse estudo, o Tempo até a Progressão Tumoral (TPT) mediano e Sobrevida livre de progressão (SLP) mediana foram de 34,0 semanas (intervalo de confiança [IC] de 95% = 22,0; 46,0). Um estudo randomizado de fase 3, duplo-cego, placebo-controlado, de sunitinibe foi conduzido em indivíduos com GIST que apresentaram intolerância ou progressão da doença durante ou após o tratamento imatinibe (mediana de dose máxima diária de 800 mg). Neste estudo, 312 indivíduos foram randomizados (2:1) para receber 50 mg de sunitinibe ou placebo, por via oral, uma vez ao dia, seguindo o esquema 4/2 até a progressão da doença ou retirada do paciente do estudo por outro motivo (207 indivíduos receberam sunitinibe e 105 indivíduos receberam placebo). O endpoint primário de eficácia do estudo foi o Tempo até a Progressão do Tumor (TPT), avaliado pela Revisão Independente, definido como o tempo decorrido entre a randomização e a primeira documentação de progressão tumoral objetiva. Os objetivos secundários incluíram SLP, TRO e Sobrevida Global (SG).

No momento da análise interina pré-especificada, o TPT mediano de sunitinibe foi de 28,9 semanas (IC de 95% = 21,3; 34,1), conforme avaliado pelo Investigador, e 27,3 semanas (IC de 95% = 16,0/ 32,1), conforme avaliado pela Revisão Independente, e foi estatística e significativamente mais longo que o TPT de 5,1 semanas (IC de 95% = 4,4; 10,1), conforme avaliado pela Revisão Independente. A diferença de SG foi estatisticamente favorável ao sunitinibe (taxa de risco [TR]: 0,491 [IC de 95% = 0,290; 0,831]); o risco de morte foi 2 vezes maior para indivíduos do braço placebo em comparação ao braço sunitinibe.

Após a análise interina positiva da eficácia e segurança, por recomendação do Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança indenpendente (DSMB), o código cego do estudo foi quebrado e aos indivíduos do braço placebo foi oferecido tratamento aberto com sunitinibe. Um total de 225 indivíduos receberam sunitinibe na fase aberta do estudo, incluindo 99 indivíduos que foram tratados inicialmente com placebo. Nesta análise final, o braço placebo incluiu aqueles indivíduos randomizados para placebo que, em seguida, receberam tratamento aberto com sunitinibe. Dos indivíduos randomizados para o braço de sunitinibe, 62,7% sobreviveram mais de 1 ano, 35,5% sobreviveram mais de 2 anos e 22,3% sobreviveram mais de 3 anos.

Requisitada nota técnica ao e-NatJus, sobreveio parecer favorável ao tratamento (evento 12, NOTATEC1):

Tecnologia: MALATO DE SUNITINIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL (GIST) CONSIDERANDO que o paciente apresentou falha de tratamento ao imatinibe CONSIDERANDO que existem evidências de benefício em sobrevida e controle de doença para o uso da Tecnologia neste contexto CONSIDERANDO que não existe, até o presente momento, avaliação por parte da CONITEC quanto à incorporação da tecnologia ao Sistema Único de Saúde, neste contexto CONCLUI-SE que HÁ EVIDÊNCIAS que suportem o uso de SUNITINIBE para o tratamento de SEGUNDA LINHA DE GIST METASTÁTICO

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

No caso concreto, conforme consta na nota técnica referida, não há medicamentos semelhantes disponíveis no SUS:

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: MALATO DE SUNITINIBE

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Trata-se de Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST), que progrediu ao tratamento com Imatinibe
É solicitada a tecnologia Sunitinibe
No SUS, não há outra opção terapêutica.
Na saúde suplementar, Sunitinibe é uma alternativa.

Existe Genérico? Sim

Existe Similar? Sim

Descrever as opções disponíveis de Genérico ou Similar: Sarra
Suzopa
Sutent

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora a imprescindibilidade do fármaco postulado, bem como a impossibilidade de sua substituição por outro medicamento.

Verifico que **não houve avaliação** pela **CONITEC** em relação ao fármaco postulado pelo requerente para a patologia da parte autora, o que dispensa a análise do item "b" do Tema 06 do STF.

Ainda, há negativa administrativa ao fornecimento do fármaco postulado pela autora (evento 1, CERTNEG10).

Por fim, no sentido da impossibilidade de custeio, sem prejuízo da própria subsistência, verifico que a parte comprovou sua hipossuficiência, uma vez que representada pela Defensoria Pública.

Assim, por todo o exposto, tenho que foram preenchidos os requisitos dos temas 1234 e 06, merecendo acolhimento a pretensão do requerente.

Ante o exposto, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **ROSENILDA DA LUZ DE JESUS DE VARGAS** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, determinando a concessão do medicamento **Sunitinibe 50mg**, na forma prescrita pelo médico assistente, enquanto necessário ao tratamento da saúde do autor.

Quando do cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar receita atualizada diretamente ao réu, semestralmente, para que seja mantido o tratamento deferido, sob pena de desobrigatoriedade do réu continuar a fornecer a prestação de saúde deferida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, das quais é isento; bem como de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC. Salienta-se, de plano, que não se desconhece o Tema nº 1076 do STJ, razão pela qual consigno, desde já, que não há omissão, obscuridade ou contradição na fixação dos honorários. O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, com acumulado mensal, uma única vez, para fins de correção e juros de mora, a partir de 09/12/2021, conforme EC 113/2021.

Em cumprimento ao disposto no Tema 06 do STF, **oficie-se** ao **Ministério da Saúde**, informando acerca do deferimento judicial do medicamento **Sunitinibe**, para tratamento de **Neoplasia Maligna do Tecido Conjuntivo - Tumor Estromal Gastrointestinal (CID 10 C49),** a fim de que seja avaliada a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do CPC, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **MAURO PEIL MARTINS, Juiz de Direito**, em 03/10/2025, às 13:55:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10092076361v15** e o código CRC **28003fe1**.